SOSPECHA CLÍNICA DE TEP
ABC · constantes · ECG · monitor · POCUS si hay operador

¿PCR, hipotensión persistente o shock?

sí

¿Trasladable a la sala de TC?

sí

no

PCR con sospecha fundada
Lisis empírica sin imagen (ERC 2025)
→ Flujograma 3

Shock con pulso: POCUS
VD dilatado sin otra causa → tratar como E (reperfusión) · ESC 2019
VD normal → buscar otra causa
Sin POCUS: lisis solo excepcional
PERT + UCI Vic de inmediato

no

¿Embarazo? → YEARS adaptado (recuadro 2.5)
si signos de TVP: eco-Doppler primero

¿Probabilidad clínica baja (gestalt <15 %)?

sí

no

PERC ¿8/8 negativos?

sí

TEP descartado

no

ELEGIR UNA SOLA VÍA (no mezclar escalas)

Vía A · Wells / Ginebra
3 niveles de probabilidad

Vía B · YEARS
todo paciente estable

Alta
angio-TC directo
HBPM si demora

Baja / intermedia
DD ajustado edad
(edad × 10 si >50 a)

0 ítems
DD <1000
→ descarta

≥1 ítem: DD <500
o edad × 10 si ≥50 a
(YEARS modif.)

¿Dímero D por encima del umbral?

no

TEP descartado

sí

ANGIO-TC PULMONAR
informe con cociente VD/VI

¿TEP confirmado?

subsegm. aislado

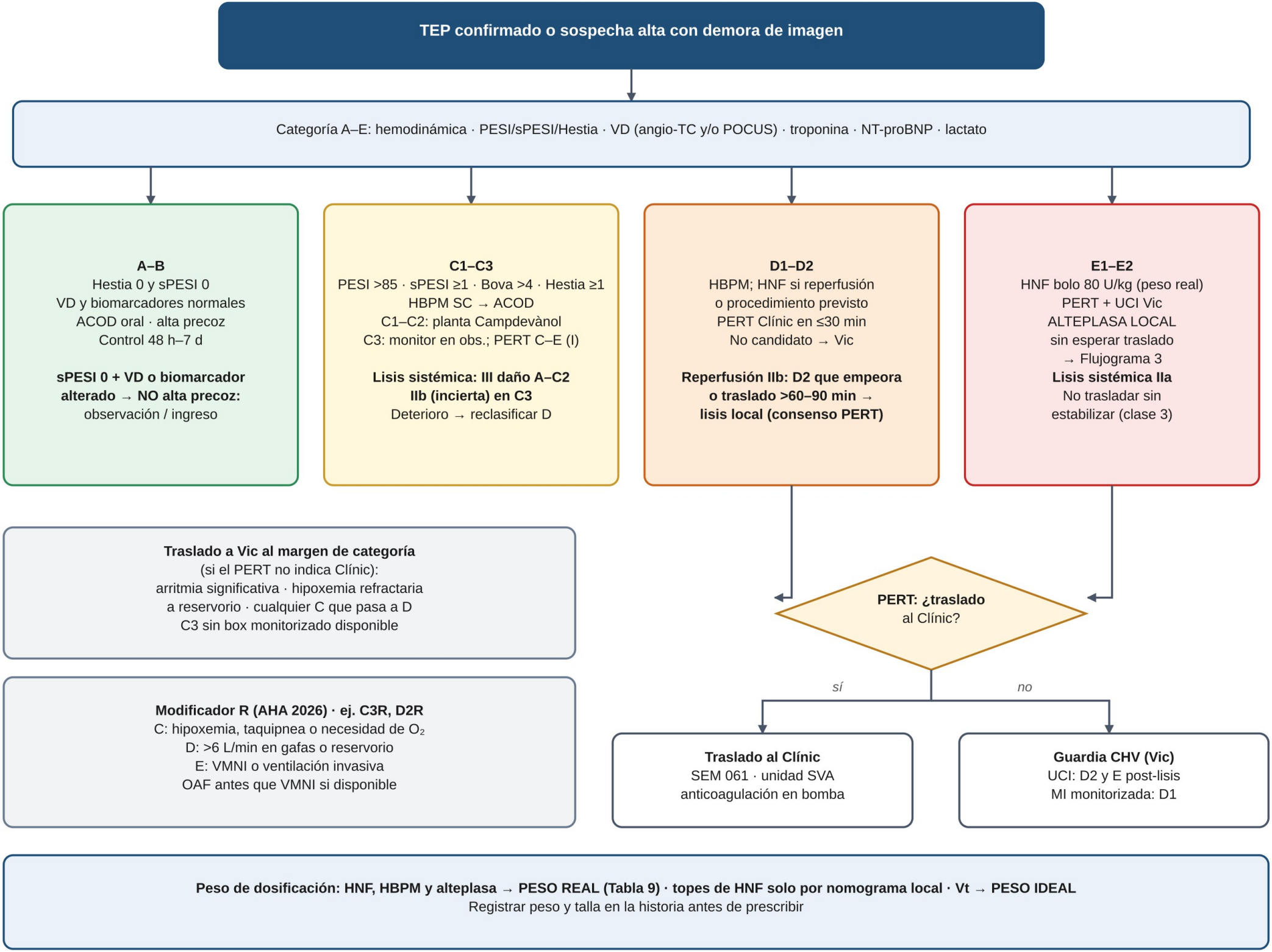
sí

no

Subsegmentario aislado:
revisar con Radiología → anticoagular
(AHA 2026); vigilancia solo excepcional

TEP descartado
(reevaluar si prob. alta
y TC no concluyente)

ESTRATIFICAR A–E
VD (TC/POCUS) + troponina
+ NT-proBNP + lactato
+ PESI/sPESI/Hestia → Flujo. 2


TEP confirmado o sospecha alta con demora de imagen
Categoría A–E: hemodinámica · PESI/sPESI/Hestia · VD (angio-TC y/o POCUS) · troponina · NT-proBNP · lactato
A–B
Hestia 0 y sPESI 0
VD y biomarcadores normales
ACOD oral · alta precoz
Control 48 h–7 d
sPESI 0 + VD o biomarcador alterado → NO alta precoz:
observación / ingreso
C1–C3
PESI >85 · sPESI ≥1 · Bova >4 · Hestia ≥1
HBPM SC → ACOD
C1–C2: planta Campdevànol
C3: monitor en obs.; PERT C–E (I)
Lisis sistémica: III daño A–C2
IIb (incierta) en C3
Deterioro → reclasificar D
D1–D2
HBPM; HNF si reperfusión
o procedimiento previsto
PERT Clínic en ≤30 min
No candidato → Vic
Reperfusión IIb: D2 que empeora
o traslado >60–90 min →
lisis local (consenso PERT)
E1–E2
HNF bolo 80 U/kg (peso real)
PERT + UCI Vic
ALTEPLASA LOCAL
sin esperar traslado
→ Flujograma 3
Lisis sistémica IIa
No trasladar sin
estabilizar (clase 3)
Traslado a Vic al margen de categoría
(si el PERT no indica Clínic):
arritmia significativa · hipoxemia refractaria
a reservorio · cualquier C que pasa a D
C3 sin box monitorizado disponible
PERT: ¿traslado
al Clínic?
sí
no
Modificador R (AHA 2026) · ej. C3R, D2R
C: hipoxemia, taquipnea o necesidad de O2
D: >6 L/min en gafas o reservorio
E: VMNI o ventilación invasiva
OAF antes que VMNI si disponible
Traslado al Clínic
SEM 061 · unidad SVA
anticoagulación en bomba
Guardia CHV (Vic)
UCI: D2 y E post-lisis
MI monitorizada: D1
Peso de dosificación: HNF, HBPM y alteplasa → PESO REAL (Tabla 9) · topes de HNF solo por nomograma local · Vt → PESO IDEAL
Registrar peso y talla en la historia antes de prescribir

CATEGORÍA E
E1: hipotensión persistente/recurrente con shock (SCAI C) · E2: shock refractario (SCAI D–E) o PCR

HNF bolo 80 U/kg IV (peso real; tope solo si lo fija el nomograma local)
Llamada simultánea: PERT Clínic + UCI Vic (no retrasa la lisis)

¿PCR?

sí

ALTEPLASA EN PCR (ERC 2025)
50 mg IV en bolo ± 50 mg a los 30 min
o 0,6–1 mg/kg (máx. 100 mg)
contraindicaciones: se ponderan
RCP ≥60–90 min tras la lisis

no

¿Contraindicación absoluta a la lisis?

sí

no

ALTEPLASA ESTÁNDAR
100 mg IV en 2 h (10 mg bolo + 90 mg)
<65 kg: máx. 1,5 mg/kg (bolo incluido)
dosis reducida 50 mg: puede considerarse (IIb)

PERT inmediato
catéter · embolectomía · ECMO-VA (Clínic)
riesgo vital sin alternativa a tiempo:
lisis excepcional, ponderada y documentada
(la dosis reducida no anula la contraindicación)

Parar la HNF durante la alteplasa (criterio CHV; ESC permite mantenerla)
TTPa c/2–4 h al terminar → reiniciar sin bolo si TTPa <2 × LSN
y ajustar por nomograma

ESTABILIZAR ANTES DE TRASLADAR (AHA 2026: clase 3, daño)
Noradrenalina · fluidos ≤500 mL solo sin congestión · O_2 titulado / OAF
IOT solo si imprescindible (riesgo de PCR en la inducción) · vigilancia neurológica y de sangrado
Cefalea, déficit o sangrado mayor → parar y TC craneal

PERT: ¿traslado al Clínic?

sí

Traslado al Clínic
SEM 061 · unidad SVA

no

UCI Vic (CHV)
monitorización post-lisis